

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 DNA合成・細胞分裂を障害	AC・EC療法 ドキシソルピシン エピルピシン シクロホスファミド タキサン系 パクリタキセル ドセタキセル その他 カペシタビン S-1 エリブリン
内分泌療法(HR陽性) エストロゲンの作用を遮断	抗エストロゲン薬 タモキシフェン フルベストラント アロマターゼ阻害薬 アナストロゾール レトロゾール エキセメスタン CDK4/6阻害薬(併用) パルボシクリブ アベマシクリブ mTOR阻害薬(併用) エベロリムス
抗HER2療法 HER2シグナルを遮断	抗HER2抗体 トラスツズマブ ペルツズマブ 抗体薬物複合体(ADC) T-DM1 T-DXd HER2チロシンキナーゼ阻害薬 ラパチニブ
その他の標的薬・免疫療法 BRCA・PD-L1・TROP2を標的	PARP阻害薬(BRCA変異) オラパリブ ICI(トリプルネガティブ) ペムブロリズマブ TROP2標的ADC ダトポタマブ デルクステカン

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 治療ラインの位置づけ(転移・再発乳がん)

対象	1次治療	2次治療	3次治療以降
HR陽性 HER2陰性	内分泌療法(アロマターゼ阻害薬・フルベストラント)+CDK4/6阻害薬	別の内分泌療法±分子標的薬、gBRCA変異ではオラパリブ	化学療法、T-DXd(HER2低発現)、ダトポタマブ デルクステカン
HER2陽性	トラスツズマブ+ペルツズマブ+タキサン	T-DXd	T-DM1、ラパチニブ+カペシタビン等
トリプルネガティブ	化学療法±ペムブロリズマブ(PD-L1陽性)	化学療法、オラパリブ(gBRCA変異)	T-DXd(HER2低発現)、エリブリン等

早期乳がんの術後:HR陽性は内分泌療法5〜10年(高リスクはアベマシクリブ2年、gBRCA変異はオラパリブ1年を追加)、HER2陽性はトラスツズマブ±ペルツズマブ1年(術前治療後に残存病変があればT-DM1)。

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	1年〜
● インフュージョンリアクション	初回投与中〜24時間					
● 悪心・嘔吐(AC/EC療法)	〜5日					
● 下痢(アベマシクリブ)	開始後1週以内に多い					
● 好中球減少(化学療法)		7〜14日目				
● 関節痛(アロマターゼ阻害薬)				開始後数か月		
● 心機能低下(抗HER2療法)				定期的に心エコー		
● 間質性肺疾患(T-DXd)			数週〜数か月、時期を問わず			
● 骨密度低下(アロマターゼ阻害薬)						年単位

● 重篤・特に注意 ● その他

押さえておきたいポイント

1. 乳がんはサブタイプ(HR・HER2)で治療体系が決まり、HER2低発現という新しい区分も登場
2. CDK4/6阻害薬は薬剤で副作用が異なる(パルボシクリブ=好中球減少、アベマシクリブ=下痢)
3. 年単位の内分泌療法は薬局が支える。継続の妨げになる副作用の聴取と、病院との情報共有が鍵